

AEDP — *afekt transformujący*

Wariant STPP, w którym obecność terapeuty jest bezpośrednio uzdrawiająca — nie tylko „ułatwiająca”. Mniej pracy z obroną, więcej bezpiecznej relacji i afektu transformacyjnego.

CZAS: 30 min · poziom zaawansowany Trauma relacyjna; potrzeba korekcyjnego doświadczenia

ŹRÓDŁO: Fosha (2000, 2009)

JAK UŻYWAĆ

Stosujesz model przyspieszonej terapii doświadczeniowo-dynamicznej (ang. *AEDP*), integrujący psychodynamikę z teorią więzi i teorią poliwalgalną. Wyrażasz ciepło **wprost** (nie „neutralną fasadę”), tworzysz poczucie bezpieczeństwa, witasz afekt w chwili jego pojawienia („niech to wybrzmi, jestem tu, nie musi Pani być z tym sama”), a po wybrzmieniu prowadzisz metaprzetwarzanie (ang. *metaprocessing*): „jak to było? co się zmieniło? co teraz w ciele?”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Centralne założenie Foshy: pacjent nie jest sam w swoich najtrudniejszych afektach — obecność terapeuty leczy bezpośrednio. Kluczowe pojęcia: **transformacja** (neologizm Foshy — właściwość pacjenta ciągnąca ku zdrowiu) oraz **afekt transformacyjny** (głęboki afekt — często żal, ulga — wybrzmiewający, gdy obrony rozluźniają się w bezpiecznej relacji). Model wywodzi się z badań nad więzią (Bowlby, Ainsworth, Tronick). Dla niektórych pacjentów neutralność jest odbierana jako porzucenie — ciepło i bezpieczeństwo są wtedy warunkiem zmiany.

01 Sześć elementów AEDP

- ① uzdrawianie od początku — pozytywne emocje od startu
- ② chwile uprzywilejowane — momenty kontaktu transformującego
- ③ śledzenie ciała (ang. *somatic tracking*)
- ④ rdzeniowe doświadczenie afektywne
- ⑤ metaprzetwarzanie — refleksja po doświadczeniu
- ⑥ oparcie na więzi

02 Stwórz bezpieczeństwo i wyraż ciepło

Nie zachowuj neutralnej fasady: „cieszę się, że Pani tu jest”, „widzę, jak to trudne”. Tempo powolne, głos cieplejszy, kontakt wzrokowy, uznanie: „nie musi Pani być z tym sama”. Zapisz, jak zbudujesz bezpieczeństwo dla tego pacjenta.

JAK STWORZĘ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

03 ✧ Witaj afekt, potem metaprzetwarzaj

W chwili pojawienia się afektu: „tak, niech to wybrzmi. Jestem tu.” Nie interpretuj zbyt szybko — obecność jest ważniejsza niż słowa. Po afekcie: „jak to było? co się zmieniło? co teraz w ciele?”. Potem waliduj nowe „ja”: „pozwoliła Pani sobie poczuć i nie rozpadła się. To ważne.”

PLAN: POWITANIE AFEKTU + METAPRZETWARZANIE

04 ✕ Granice i dbałość o siebie

AEDP jest emocjonalnie intensywna dla terapeuty — wymaga superwizji i własnej regulacji. Nie dla każdego pacjenta: osoba z obronami prymitywnymi może być przytłoczona ciepłem, więc stopniuj. Zapisz, na co uważać u tego pacjenta.

NA CO UWAŻAĆ; JAK STOPNIOWAĆ

Klucz: nie musisz stosować AEDP w całości — ale jej narzędzia (metaprzetwarzanie, witanie afektu, wyraźne bezpieczeństwo) są użyteczne w każdej STPP, zwłaszcza z pacjentami po traumie relacyjnej. Nie wszystko, co neutralne, jest „bezzstronne”: dla niektórych pacjentów neutralność bywa odebrana jako porzucenie.